

Jak żyć *po terapii*

OCD jest chroniczne — jak cukrzyca wymaga ciągłej pielęgnacji. Dawka maleje, ale praktyka trwa.

CZAS: 10–15 min/tydz. utrzymania Po zakończeniu formalnej terapii

ŹRÓDŁO: Hiss, Foa i Kozak (1994); McKay i wsp. (2015); NICE CG31

JAK UŻYWAĆ

Wykonuj **mini-ekspozycje 1-2× tygodniowo** nawet w dobrym samopoczuciu — utrzymują formę. Rozpoznawaj *ciche unikanie*: „nie idę tą ulicą — preferencja czy unikanie?”. Akceptuj „*fale*” jako normalne — wracaj do codziennych ćwiczeń na 2–4 tyg. **Sesje odświeżające** co 3–6 mies. SSRI *nigdy* nie odstawiaj bez konsultacji (NICE: min. 12 mies., stopniowo).

DLACZEGO TO DZIAŁA

OCD jest **zaburzeniem chronicznym**. Bez profilaktyki ~50% *nawrotów*; z profilaktyką ~20% (Hiss, Foa i Kozak, 1994). „Wyzdrowiałem” jest **pułapką** — zarządzanie OCD trwa *całe życie*, ale dawka maleje (z 60 min ERP dziennie do 10–15 min utrzymania + szybka reakcja na sygnały nawrotu). Mechanizm: regularna praktyka utrzymuje **uczenie inhibicyjne** (model hamowania, Craske); *sesje odświeżające* reaktywują ślad pamięci bezpieczeństwa. McKay i wsp. (2015): praktyka 1–2× tyg. + boosty 1–3 co 3–6 mies. obniżają nawroty z ~50% do ~20%. NICE CG31: SSRI minimum 12 mies. po remisji, odstawianie *stopniowe* i pod kontrolą lekarza.

01 ? Pułapka „wyzdrowienia”

PUŁAPKA — „MAM TO ZA SOBĄ”

Po terapii pacjent czuje się dobrze, **porzuca ćwiczenia**. „Mam to za sobą”.

Wkrada się *ciche unikanie*. Stresor reaktywuje cykl. ~50% **nawrotów** w ciągu 12 mies.

ZDROWA POSTAWA — PIELĘGNACJA

OCD jest chroniczne *jak cukrzyca*. Wymaga **ciągłej pielęgnacji** — ale w mniejszej dawce.

1–2 mini-ekspozycje/tydz. + sesje boostery. ~20% **nawrotów** w ciągu 12 mies.

02 ☉ Cztery zasady utrzymania

1 · MINI-EKSPOZYCJE

1-2× tygodniowo wykonuj ekspozycję z hierarchii — nawet gdy czujesz się dobrze. To *trening* — utrzymuje „formę”.

2 · ROZPOZNAWAJ CICHE UNIKANIE

Subtelne formy unikania wkradają się: „*nie idę tą ulicą, bo tam jest szpital*” — czy to preferencja, czy unikanie?

3 · OCD ZMIENIA TEMAT

Z kontaminacji na sprawdzanie, ze sprawdzania na intruzje. **Metoda ta sama** (ERP + RP). Nie bój się „nowego tematu”.

4 · „FALE” SĄ NORMALNE

OCD wraca przy stresie, zmęczeniu, chorobie, zmianach. *To normalne*. Wróć do codziennych ćwiczeń na 2–4 tyg.

03 Mój plan utrzymania

JAKĄ MINI-EKSPOZYCJĘ WYKONAM 1×/TYG.

— konkretna z hierarchii

W JAKI DZIEŃ TYGODNIA

— stała pora

MOŻLIWE „CICHE UNIKANIA” W MOIM ŻYCIU

— co warto sprawdzić

TERMIN PIERWSZEJ SESJI ODŚWIEŻAJĄCEJ

— za 3 mies. od teraz

04 SSRI — zasady długoterminowe

Minimum 12 mies. kontynuacji po osiągnięciu remisji. Skrócenie nasila ryzyko nawrotu.

Nigdy nie odstawiaj samodzielnie. Zawsze konsultacja z lekarzem. Odstawienie stopniowe, pod kontrolą.

Odstawianie trwa zwykle 6–8 tyg. Stopniowe redukcje dawki o 25% co 2 tyg. Obserwuj objawy.

Po odstawieniu — wzmocnij praktykę ERP. Risk nawrotu po SSRI bez ERP: 50–70% (Simpson 2004).

05 Postawa — samowspółczucie i wytrwałość

OCD nie jest moją winą — to zaburzenie biologiczno-psychologiczne. Ale zarządzanie nim jest *moją odpowiedzialnością*. Wytrwałość, nie perfekcjonizm. „Fale” nie są porażką — są częścią zaburzenia.

„Mam OCD i ono nie definiuje mojego życia. Pielęgnuję je jak zdrowe ciało — codziennymi małymi gestami.”

Klucz: Hiss, Foa i Kozak (1994): pacjenci utrzymujący *regularną praktykę* + sesje boostery mają nawroty **2,5× rzadziej** niż grupa bez praktyki. Mechanizm: utrzymanie *uczenia inhibicyjnego* (model hamowania Craske 2014) wymaga periodycznej reaktywacji śladu. Po 2–3 latach utrzymania praktyka może być rzadsza — ale *nigdy nie zerowa*. NICE CG31: leczenie OCD jest **długoterminowym partnerstwem** pacjenta z systemem opieki. Klucz emocjonalny: traktuj siebie z *cierpliwością*, jak osobę uczącą się grać na instrumencie — nie chodzi o doskonałość, chodzi o *regularność*. Łącz z profilaktyką nawrotów.